

PORTADA

Institución: Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa (IUTECP)

Asignatura: Enfermería Pediátrica / Pasantías Clínicas

Título: Proceso de Atención de Enfermería Aplicado a Recién Nacido a Término con Diagnóstico de Lúes Connatal Ubicado en la Unidad de Retén / Neonatología del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas en el Mes de Agosto - Septiembre de 2026

Fecha: Septiembre de 2026

OBJETIVOS

Objetivo General:

Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en el recién nacido Liam Emanuel Capriles con diagnóstico de Lúes connatal y sepsis neonatal precoz, hospitalizado en el servicio de Retén / Neonatología, para restaurar su estado de salud y prevenir complicaciones mediante intervenciones de enfermería jerarquizadas.

Objetivos Específicos:

1. Valorar al recién nacido recopilando datos objetivos, anamnesis materna y resultados paraclínicos (hematología completa, procalcitonina y VDRL).
2. Identificar los patrones funcionales de Marjory Gordon que se encuentran alterados.
3. Formular los diagnósticos de enfermería (reales y de riesgo) jerarquizados según las necesidades prioritarias del recién nacido.
4. Planificar y ejecutar las intervenciones de enfermería enfocadas en el esquema terapéutico prescrito (Penicilina Cristalina y Cefotaxima).
5. Evaluar la evolución clínica del paciente durante su estancia hospitalaria.

HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA

Nombre del Paciente: Liam Emanuel Capriles

Fecha de Nacimiento: 31-07-2026 (Hora: 9:07 pm)

Edad: 5 días de nacido

Sexo: Masculino

Cédula de Identidad: 31.741.479 (asignada)

Historia Clínica (HC): 31-91-52

Certificado de Nacimiento: 12388442

Datos Antropométricos: Peso al nacer: 3.300 kg | Talla: 50 cm | CC: 36 cm | CT: 33 cm | CA: 32 cm

Madre: Lisneidys Capriles (27 años) | Tlf: 04164906479

Dirección: C/ Brisas del Valle s/n, Sector Nueva Esperanza - El Tigrito, Municipio Guanipa, Estado Anzoátegui.

Servicio: Retén / Neonatología

RESUMEN DEL CASO Y ENFERMEDAD ACTUAL

Se trata de recién nacido masculino de 39 semanas de gestación por Ballard (RNAT / AEG), obtenido por cesárea segmentaria el 31/07/2026 a las 9:07 pm. Producto de madre de 27 años de edad, IV gestación, con embarazo mal controlado (1 control prenatal). Como antecedentes maternos destaca VDRL 1/8 en II trimestre no tratado, vaginosis en I trimestre tratada con óvulos de Clinfol por 7 días, niega ITU y HIV (-).

Al nacer, el producto lloró y respiró espontáneamente; se le realizó aseo, colocación de clamp umbilical, administración de Vitamina K, gotas oftálmicas y vacuna anti-Hepatitis B. Es evaluado por el servicio de Pediatría e ingresado al servicio de Retén por antecedentes maternos patológicos (VDRL materno positivo no tratado) con diagnósticos de Lúes connatal A/D y Sepsis neonatal precoz A/D.

A los 5 días de evolución hospitalaria (05/08/2026), el recién nacido se encuentra en cuna en regulares condiciones generales, activo, afebril al tacto, tolerando vía oral, con llanto fuerte, tono muscular conservado y vía periférica permeable para cumplimiento de esquema antibiótico.

EXÁMENES DE LABORATORIO Y PARACLÍNICOS

Hematología Completa (04/08/2026):

Leucocitos: 9.400 /mm³ | VAN: 5.734 /mm³

Eritrocitos: 3,93 /mm³

Hemoglobina: 15,1 g/dL | Hematocrito: 45 %

VCM: 114,5 fL | HCM: 38,4 pg | CHCM: 33,5 %

Segmentados / Neutrófilos: 61 % | Linfocitos: 31 % | MID%: 8 %

Plaquetas: 168.000 /mm³ | VPM: 10,0 fL

Gota Gruesa / Extendido: Negativo (no se observaron formas compatibles con Plasmodium spp.).

Quimioluminiscencia: Procalcitonina (04/08/2026): 0,82 ng/mL (Posible infección / infección sistémica).

Inmunología: VDRL: Reactivo 1/4 (02/08/2026).

DIAGNÓSTICO MÉDICO (DEFINICIÓN Y AFECTACIÓN CLÍNICA)

1. Recién Nacido a Término (39 semanas por Ballard) / Adecuado para la Edad Gestacional (RNAT / AEG)

¿Qué es?: Condición del neonato nacido entre las semanas 37 y 41 de gestación cuyo peso al nacer (3.300 kg) se ubica dentro del rango esperado para su edad gestacional.

¿Qué afecta?: Representa un factor protector. Indica que el neonato completó su maduración física y neurológica en el útero, lo que le otorga una mejor capacidad de adaptación a la vida extrauterina en comparación con un prematuro.

2. Lúes Connatal (Sífilis Congénita) A/D

¿Qué es?: Infección de transmisión vertical en la que la bacteria Treponema pallidum se transmite de la madre infectada (con antecedente de VDRL 1/8 no tratado) al recién nacido durante la gestación.

¿Qué afecta?: Afecta la salud general del neonato al ponerlo en riesgo de desarrollar alteraciones multiorgánicas (cutáneas, óseas, hepáticas y neurológicas). En este paciente, el hallazgo de VDRL reactivo (1/4) exige la administración inmediata del esquema completo de Penicilina Cristalina para eliminar el microorganismo y prevenir secuelas a largo plazo.

3. Sepsis Neonatal Precoz A/D

¿Qué es?: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se presenta en las primeras 72 horas de vida, secundario a la exposición del recién nacido a microorganismos patógenos en el canal del parto o antecedentes infecciosos maternos (vaginosis bacteriana y embarazo mal controlado).

¿Qué afecta?: Afecta la estabilidad hemodinámica y el estado inmunológico del lactante, comprometiendo su bienestar general. Se evidencia por la elevación de la procalcitonina (0,82 ng/mL) e hipotermia leve (34.8 °C), requiriendo tratamiento antibiótico de amplio espectro (Cefotaxima) y monitorización continua para evitar una falla multiorgánica.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS (MATERNOS / PERINATALES)

Antecedentes Maternos: IV gestación, embarazo mal controlado (1 control). VDRL 1/8 en II trimestre no tratado, HIV (-) (23/07/26). Vaginosis bacteriana en I trimestre tratada con óvulos de Clinfol por 7 días. Niega ITU.

Antecedentes Perinatales: Nacido el 31/07/2026 a las 9:07 pm por cesárea segmentaria. Peso: 3.300 kg, Talla: 50 cm. Lloró y respiró al nacer. Profilaxis neonatal cumplida (Vitamina K, gotas oftálmicas y vacuna Hepatitis B).

EXAMEN FÍSICO (CEFALOCAUDAL)

(Información tomada de la historia clínica)

Signos Vitales: FC: 129 bpm | FR: 31 rpm | Temp: 34.8 °C

Piel: Tez sonrosada, normotérmica, turgor y elasticidad conservada, llenado capilar < 3 segundos.

Cabeza y Cara: Normocéfalo, fontanelas normotensas. Ojos simétricos, isocóricos. Oídos con pabellón auricular normoimplantado. Nariz con narinas permeables. Boca con mucosa húmeda y paladar indemne.

Cardiopulmonar: Tórax simétrico, normoexpansible. Ruidos respiratorios presentes sin agregados. Ruidos cardíacos rítmicos y regulares.

Abdomen: Batracóide, blando, depresible, no doloroso a la palpación. RHA presentes.

Anogenital: Genitales normoconfigurados, ano permeable.

Extremidades: Simétricas, eutróficas, sin edemas.

Neurológico: Vigil, activo, llanto fuerte, succión adecuada, tono muscular conservado.

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON (ALTERADOS)

1. Patrón 1: Percepción - Manejo de la Salud: Alterado por proceso infeccioso activo (Lúes connatal A/D) y riesgo de sepsis neonatal precoz secundario a antecedente materno de VDRL (+) no tratado durante la gestación.

2. Patrón 2: Nutricional - Metabólico: Riesgo de alteración secundario al cumplimiento de tratamiento antibiótico endovenoso y monitoreo de la tolerancia de la vía oral.

PLAN DE CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (5 DIAGNÓSTICOS NANDA)

1. Protección ineficaz R/C respuesta inmune inmadura y transmisión vertical infecciosa E/P VDRL reactivo (1/4) y diagnóstico de Lúes connatal.

Objetivo: El recién nacido mantendrá la infección controlada sin signos de deterioro sistémico.

Intervenciones:

Administrar Penicilina Cristalina (150.000 UI/kg/día = 247.000 UI) VEV c/12h.

Administrar Cefotaxima (150 mg/kg/día = 247 mg) VEV c/12h.

Monitorear la respuesta al tratamiento antibiótico y vigilar signos de reacción adversa.

2. Riesgo de infección sistémica R/C susceptibilidad del recién nacido a la diseminación bacteriana (sepsis neonatal precoz).

Objetivo: Prevenir la progresión a sepsis severa durante la estancia en el servicio de Retén.

Intervenciones:

Mantener estricta técnica aséptica en el manejo y canalización de la vía venosa periférica.

Evaluar periódicamente los reportes de laboratorio (Leucocitos: 9.400 /mm³, Procalcitonina: 0,82 ng/mL).

Vigilar presencia de signos de alarma (hipotermia, letargia, llenado capilar lento).

3. Riesgo de alteración de la temperatura corporal R/C inmadurez del centro termorregulador e hipotermia leve registrada (34.8 °C).

Objetivo: Restablecer y mantener la normotermia (36.5 °C - 37.5 °C).

Intervenciones:

Mantener al neonato abrigado en cuna con confort térmico adecuado.

Controlar y registrar la temperatura corporal de forma horaria hasta su estabilización.

4. Riesgo de interrupción de la lactancia materna R/C hospitalización en el servicio de Retén.

Objetivo: Garantizar el mantenimiento de la lactancia materna y una adecuada nutrición.

Intervenciones:

Promover la entrada de la madre para fomentar el amamantamiento y el vínculo afectivo.

Administrar suplementación según esquema médico (Ácido Fólico 0,5 cc VO OD, Henroic 0,5 cc VO OD, Complejo B 0,5 cc VO OD).

5. Disposición para mejorar el conocimiento materno R/C cuidados del neonato y adherencia al tratamiento al alta.

Objetivo: La madre expresará comprensión sobre el manejo y seguimiento de la patología.

Intervenciones:

Orientar a la madre sobre la importancia de completar el tratamiento con Penicilina.

Educar sobre la identificación precoz de signos de alarma (rechazo al alimento, fiebre, somnolencia).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (PERSONALES)

Conclusiones: El abordaje de enfermería en el servicio de Retén es fundamental para la detección e intervención oportuna en recién nacidos expuestos a infecciones de transmisión vertical. La administración rigurosa del tratamiento antibiótico con Penicilina Cristalina y Cefotaxima, sumada a la vigilancia constante de las constantes vitales, permitió mantener la estabilidad clínica del recién nacido Liam Capriles.

Recomendaciones: Fortalecer las estrategias de control prenatal en el primer nivel de atención para garantizar el despistaje y tratamiento oportuno del VDRL en la embarazada, evitando la transmisión vertical de la sífilis y reduciendo la morbilidad neonatal.

¿QUÉ APRENDÍ EN LAS PASANTÍAS?

ESTRUCTURA

La estructura del PDF es la siguiente: primero la portada, luego el objetivo del caso con el objetivo general y los objetivos específicos, luego la importancia del caso, luego la historia de enfermería, luego el resumen del caso, continúa el diagnóstico médico, el IDX, los antecedentes personales y familiares, los patrones funcionales de la persona con todos los patrones, los diagnósticos de enfermería y objetivos esperados, el diagnóstico real, todo eso, el razonamiento científico, la evaluación, las intervenciones de enfermería, todo eso. Cada diagnóstico debe tener las intervenciones y el razonamiento científico. Luego sigue el examen físico segmentario y luego las conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que esa es la estructura del PDF. De todas formas, trabaja con la información que tienes y trabaja con la información que te voy a pasar en eso. Y las partes que falten, entonces colocas el título nada más y continuas en la siguiente página o continuas de seguido con el siguiente punto.